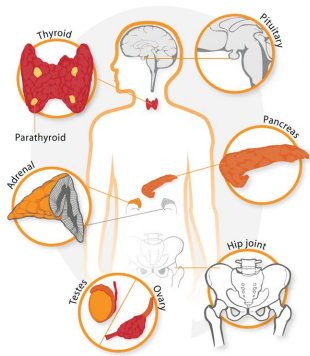


DM Tipe 2



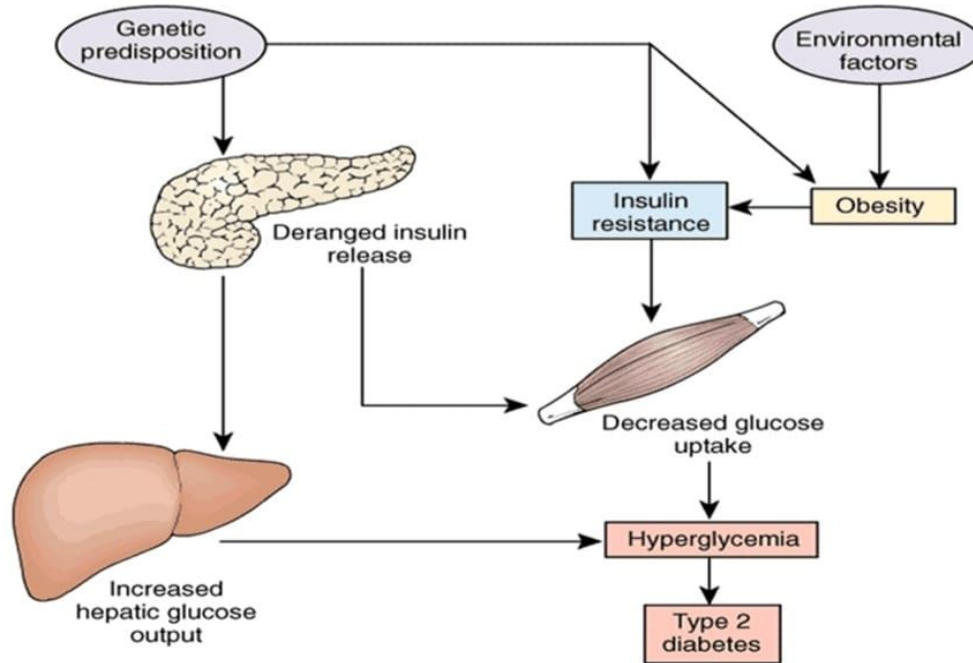
Diabetes melitus tipe 2	4
Diabetes melitus tipe 2 pada anak	2

Muhammad Azka Al atsari, S.Ked

Definisi DM Tipe 2

- Diabetes melitus merupakan kondisi hiperglikemia persisten yang disebabkan oleh defek pada sekresi insulin, aksi insulin atau keduanya.
- DM tipe-2 merupakan hasil dari perpaduan antara resistensi insulin dan defisiensi insulin relatif (kompensasi sekresi insulin yang tidak adekuat).
- Kegagalan sel beta pada DM tipe-2 tidak diperantarai oleh proses autoimun. Oleh karena adanya resistensi insulin maka konsentrasi insulin dalam sirkulasi bisa meningkat namun juga bisa rendah jika disfungsi sel beta lebih berat.

Patogenesis



Kategori	Faktor Penyebab
Inhibitor Prareseptor	Antibodi terhadap insulin → DM tipe 1
Inhibitor Reseptor	<i>Down regulation receptor</i> akibat: - Hiperinsulinisme - Hiperinsulinisme primer (adenoma sel β) - Hiperinsulinisme sekunder terhadap defek pascareseptor (obesitas, sindrom Cushing, akromegali, kehamilan) - Hiperinsulinisme akibat hiperglikemia yang lama (diabetes melitus, pasca uji toleransi glukosa)
Kelainan Pascareseptor	Respons yang buruk terhadap organ sasaran akibat: - Obesitas - Penyakit hepatic - Inaktivitas massa otot
Kelebihan Hormon	- Glukokortikoid - Hormon pertumbuhan - Kontrasepsi oral - Progesteron - Somatomotropin korionik manusia - Katekolamin - Tirosin

Manifestasi Klinis

- Sering haus
- Sering BAK
- Sering lapar atau lelah
- BB turun
- Luka sulit sembuh
- Kulit kering dan gatal
- Kebal rasa di kaki atau kesemutan
- Pandangan kabur



Excessive thirst



Excessive hunger



Unexplained weight loss



Blurred vision



Slow healing of cuts and sores



Fatigue



Vaginal yeast infections



Frequent urination, including frequent full diapers in infants and bedwetting in children

Diagnosis DM

BOKS 1. DIAGNOSIS DM MENURUT AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (ADA)

Diagnosis DM dapat ditegakkan dengan salah satu kriteria berikut:

Glukosa plasma puasa ≥ 126 mg/ dL (7.0 mmol/L)

* puasa berarti tanpa asupan kalori selama setidaknya 8 jam.

Glukosa plasma *post-prandial* ≥ 200 mg/dL (11.1 mmol/L)

*Pembebanan dilakukan sesuai dengan pedoman WHO, menggunakan 75g glukosa (atau 1,75g/kg bila kurang dari 75g) dilarutkan dalam air

Gejala klinis diabetes melitus disertai kadar glukosa plasma sewaktu ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L)

* sewaktu, berarti tanpa memperhatikan jarak waktu dengan makan terakhir

* gejala klasik DM: poliuria, polidipsia, nokturia, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang tidak jelas

HbA1c $> 6,5\%$

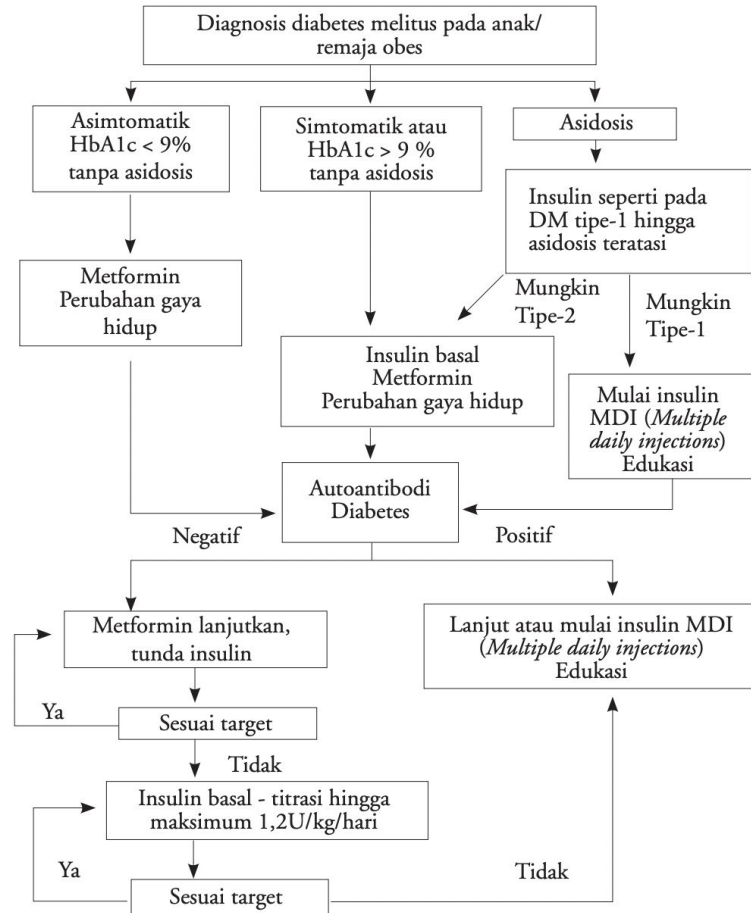
* Pemeriksaan kadar HbA1c harus dilakukan di fasilitas laboratorium yang terstandarisasi

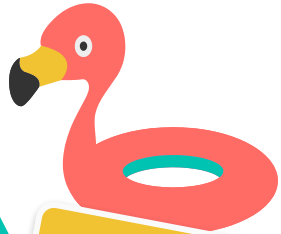
KARAKTERISTIK	TIPE-1	TIPE-2
Genetik	Poligenik	Poligenik
Usia	6 bulan sampai dewasa muda	Bervariasi: bisa lambat dan ringan, sering tanpa gejalanya, sampai berat
Gambaran Klinis	Biasanya akut	Bervariasi: perlahan, ringan, sampai berat
Autoimunitas	Ya	Tidak
Ketosis	Sering	Jarang
Obesitas	Sesuai dengan prevalensi obesitas di populasi	Lebih sering
Acanthosis nigricans	Tidak	Ya
Persentase dari seluruh DM anak	Biasanya $> 90\%$	Pada umumnya $< 10\%$ (60-80% di Jepang)
Orang tua menderita DM	2-4%	80%

Tatalaksana

- Pada umumnya sama dengan DM tipe I, kecuali terapi substitusi dengan preparat-preparat hormon insulin yang diberikan pada DM tipe I
- **Terapi dietetik → TERPENTING**
- Bertujuan mengurangi masukan kalori dan menurunkan berat badan
- Khususnya pada DM tipe II anak dan remaja yang obes
- **Obat-obatan :**
Metformin (500 mg/24 jam/oral)

ALUR TERAPI DM TIPE-2





Endokrin



Pediatri

Arigato

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#)